

通称为《千金方》。他还十分重视妇婴疾病的治疗,无论在妊娠、产程、分娩以及乳母须知、婴儿护理等方面,都有不少合理的创见,并为其后妇、儿专科的建立奠定了基础。

结语

从上述论述可以看出,我国传统的道教对中医药学从理论的构建到临床医疗实践,都作出了重大贡献。源远流长的道教文化蕴藏有极深的生命科学智慧,即使是在科学和现代医学高度发展的今天,仍有一定的应用价值和重要的指导意义。中医药不管在理论方面还是在临床医疗实践方面,都从道教思想和道教经典中汲取丰富的养分,时至今日,仍可将其作为解决现代中医发展问题的一种重要的理论资源,促进中医药在新时代的传承与创新,也可藉此弘扬我国优秀的传统文化。

参 考 文 献

- [1] 孙爱云,张金波.浅谈道家哲学思想对中医学的影响.中国中医药现代远程教育,2009,7(11):81-82
- [2] 周海金.道家与中医.南京中医药大学学报(社会科学版),

2007,8(1):34-37

- [3] 管子.北京:商务印书馆,1937:53,78
- [4] 司马迁.史记.北京:中华书局,1982:234
- [5] 李晓红,李邓辉.浅论道家思想对中医学的影响.江西中医药,2008,39(1):16-17
- [6] 孙广仁.中国传统文化与中医学.济南:山东大学出版社,2002:102
- [7] 孙广仁.中医基础理论难点解析.北京:中国中医药出版社,2001:186
- [8] 马伯英.中国医学文化史.上海:文汇出版社,1993:275
- [9] 马清翠,路玉良.浅论道家在中医学形成和发展中的影响.中医学报,2010,25(2):242-243
- [10] 陈森镇.道家道教对中医学发展前期的影响.厦门大学学报(哲社版),1993(1):65-70
- [11] 范晔.后汉书.北京:中华书局,1965:2321
- [12] 孙兆杰,王洪琦.《太平经》中五脏分证思想探析.中华中医药杂志,2016,31(4):1181-1183
- [13] 太平经合校.北京:中华书局,1960:179
- [14] 葛洪.肘后备急方.北京:人民卫生出版社,1956:27
- [15] 程志立,顾澎,国华,等.孙思邈与炼丹术和丹药服食养生及思考.中华中医药杂志,2016,31(3):1109-1112

(收稿日期:2016年12月18日)

·仁心雕龙·

基于治未病思想指导下的疾病风险 预警系统研究

吴长汶¹, 朱龙¹, 唐娜娜², 李书楠¹, 李灿东¹

(¹福建中医药大学中医证研究基地, 福州 350108, ²江西中医药大学附属医院, 南昌 330006)

摘要: 随着人类对生命理解的不断深入, 追求健康的意愿也更加强烈, 使得中医学“治未病”理念日益受到重视, 但由于传统的“治未病”理论缺乏可操作性平台, 限制了其在临床实践中的广泛应用。文章旨在论述把中医诊断学与现代临床流行病学研究相结合, 在证素辨证和体质辨识基础上, 建立状态与疾病相关的模型, 构建慢病风险预警系统, 对高血压病、糖尿病等相关人群慢病的风险进行评估, 发出风险预警, 为慢病防控和治未病健康工程提供技术支撑。

关键词: 慢病; 疾病风险预警; 治未病; 状态; 健康管理

基金资助: 国家自然科学基金项目(No.81473595), 福建省科技厅省高校产学研结合项目(No.2016Y51010059)

Disease risk early warning system research under the preventive treatment of disease in TCM

WU Chang-wen¹, ZHU Long¹, TANG Na-na², LI Shu-nan¹, LI Can-dong¹

(¹Research Base of Traditional Chinese Medicine Syndrome, Fujian University of Chinese Medicine, Fuzhou 350108, China;

²The Affiliated Hospital of Jiangxi University of Chinese Medicine, Nanchang 330006, China)

Abstract: With deepening understanding of life, people more and more intensely pursue health, so making the concept of preventive treatment of disease in TCM being increasingly valued. However, due to the lack of operational platform, the

通讯作者: 李灿东, 福建省福州市闽侯大学城华佗路1号福建中医药大学中医证研究基地, 邮编: 350108, 电话: 0591-22861513

E-mail: fjzyld@126.com

traditional 'preventive treatment of disease' theory has been limited its wide application in clinical practice. The purpose of this paper is to explain how to combine traditional Chinese medicine diagnosis and modern epidemiology research. On the basis of syndrome elements differentiation and constitution differentiation, we hope to establish a model of state and disease and a system of chronic disease risk early warning, which will help assess the risk and deliver a risk warning aiming at common chronic diseases such as hypertension, diabetes and other related diseases. All of these will provide technical support for the prevention and treatment of chronic diseases and the platform of preventive treatment of disease in TCM.

Key words: Chronic disease; Disease risk of early warning; Preventive treatment of disease; State; Health management

Funding: National Natural Science Foundation of China (No.81473595), Production Combined with Education Project in University of Science and Technology Department of Fujian (No.2016Y51010059)

进入21世纪以来,医学模式逐渐从“疾病医学”向“健康医学”转变。为了有效提高人民的健康水平、遏制医疗经费的过快增长,世界卫生组织和发达国家近年来提倡由传统的疾病管理转向全民健康管理,即通过健康管理的手段达到“健康促进”的目的^[1]。这与中国传统医学所提倡的“治未病”思想不谋而合。“治未病”源于《素问·四气调神大论》:“是故圣人不治已病治未病”,是未病先防、既病防变、瘥后防复的总称,其关键在于如何对疾病的风险进行预警。

什么是疾病风险预警

虽然“治未病”理论在应用研究方面取得了进展,国家中医药管理局支持成立的各地“治未病中心”试点单位也取得了良好的成果。“治未病”未曾达到现阶段的盛行,如今各种健康管理机构、治未病机构虽有波涛汹涌的井喷之势,却也有乱象众生之实。要真正实现治未病,首先就要有预知疾病的技术和手段,这就是疾病风险预警系统。风险预警就是通过机体细微的变化,即由此知彼、由表及里地了解健康状态并做出评估以达到治未病的作用,所谓:“一叶落而知天下秋”,“础润而雨,月晕而风”^[2]。

1. 疾病风险预警 疾病风险预警的疾病指的是慢病。慢病即慢性非传染性疾病的简称,主要是指那些发病率、致残率、病死率较高和医疗费用昂贵,并有明确预防措施的疾病^[3]。包括心脑血管病,如高血压病、冠心病、脑卒中等;代谢性疾病,如肥胖、糖尿病、痛风等;恶性病质慢性病,如肺癌、胃癌、肝癌等;其他慢性病,如精神类疾病,精神、心理障碍,过劳症,更年期综合征等一系列虽不能传染但也不能自愈,需要长期综合干预和治疗的一类疾病^[4]。预警是指疾病发生之前,根据疾病的总结规律或观测得到的可能性前兆,发出紧急信号,报告危险情况,以避免其危害在不知情或准备不足的情况下发生,从而最大程度减轻危害所造成损失的行为^[5]。

2. 中、西医学架构下两种疾病风险预警的差异和不足 西医学的疾病风险评估已逐步发展成为流行病学、卫生统计学、行为医学、心理学等多种学科的交叉应用技术。近年来,国内外学者通过应用

数据挖掘技术,结合循证医学对慢病患者包括医学影像、各项理化指标,还包括年龄、性别、身高、体重、既往病史等大量数据分析,找出慢病相关风险因素,从而进行该病的风险预警。因此,西医学的疾病风险预警更具客观化、标准化、同质化和普及化。但它更多的是从疾病本身去研究,而忽略了疾病的载体——人的因素,以及影响疾病和人体的外环境因素。由此所得到的预警就难免会挂一漏万。

中医学对健康有很多独到的认识,对疾病的病因病机的解释与现代医学的危险因素有不同之处,如中医学认为,骨质疏松症早期身体功能的改变,与肾虚有密切关系,因此,如果受检者呈肾虚状态,则其发生骨质疏松的风险就会大大提升。但是对于如何运用中医药技术对可能引起疾病的危险因素进行系统评估方面的研究,从目前掌握的资料来看,国内还鲜有文献提及,国外涉及这方面的文献也不多^[6]。目前众多的健康风险评估模型中,大多以现代医学中的疾病危险因素作为变量,没有涉及中医学方面的相关内容。

有研究利用“中医体质及健康状况自填式问卷”结合现代检测手段收集健康信息,由专家提供对个体或群体的健康进行健康及疾病的风险评估^[6]。但是专家不可复制,大样本时操作不了,很难系统化研究;风险评估多仅有定性,没有量化,不利于推广实施疾病风险预警。因此,本文通过梳理中医学有关“治未病”的理论,参考现代医学疾病风险预警的方法,提出把中医诊断学原理与现代临床流行病学研究相结合,在证素辨证和体质辨识基础上,建立状态与疾病相关的模型,构建慢病风险预警系统,对慢病的风险进行评估,发出风险预警。使得中医的疾病风险预警更强调整体性、全面性和个性化,为慢病防控和治未病健康工程提供技术支撑。

疾病风险预警的意义

疾病风险预警已经是健康管理研究的热点问题。疾病风险预警在中医健康管理的应用,是为了服务于“中国式”医改(使医疗卫生工作重心下移、关卡前移)的重大需求;是医学目的由治疗疾病为中心

向维护健康为中心的需求。目前我国健康管理相关研究起步较晚,健康管理理念与发达国家差距很大,体检缺乏针对性,一般不进行健康风险评估和预警,造成医疗经费的浪费。如果采用全民健康管理,进行健康状态评估,提早针对疾病风险发出预警,进而有针对性地进行干预,就可以提高人民的健康水平,遏制医疗经费的过快增长。《泰定养生主论》^[7]道:“与其病后求良药,孰若病前能自防”。要自防,首先要能够对可能发生的疾病进行风险预警。本文梳理了中医学关于疾病的病因、发病、传变和转归,主要归纳出疾病未成的预警、未发的预警、未传的预警、瘥后复发的预警等。

1. 疾病未成阶段的风险预警 孙思邈在《千金要方·论诊候》^[8]书中记载:“古人善为医者……上医医未病之病,中医医欲病之病,下医医已病之病”。如何医未病之病?古今医家无不孜孜汲汲寻求其门径道路。《医学源流论·病同因别论》^[9]曰:“凡人之所苦谓之病;所以致此者谓之因”。说明疾病的形成必定要有其原因,即病因。因此要预防疾病的形成,就必需先能对产生疾病的病因进行风险预警,防止致病因素变在病因。根据中医学的病因学理论,对慢病风险预警而言,就是要能对六淫、七情、饮食、劳逸,以及痰饮、瘀血、结石等的产生进行预警。

1.1 六淫致病风险预警 六淫致病,一是自然界气候变化异常,如六气太过或不及;非其时有其气;气候变化过于急躁。因此,可以建立一套以“五运六气”结合现代气象信息的预警系统进行风、火、暑、湿、燥、寒等易感之邪的预警。如2016年水运太过,少阳相火司天,厥阴风木在泉,则提示本年以寒为主(寒冷早来或比往年冷);但上半年火热较盛,下半年风多,根据胜复理论,本年湿也较盛。二是人体的正气不足,整个机体处于“虚弱”状态,如气虚体质易感风邪;阳虚体质易感寒邪;阴虚体质易感热邪、燥邪等。因此,进行气候预警的同时应当结合体质状态辨识来预警。

1.2 七情致病风险预警 七情致病,一是强烈或/和持久的情志刺激,如过怒伤肝;过喜伤心等。二是人体正气虚弱,脏腑精气虚衰,对情志过激的调节能力下降。情志舒畅,则正气强盛,邪气难以入侵,或虽受邪也易祛除。突然强烈的情志刺激可扰乱气机、伤及内脏而致疾病突发。如临床中常见的突发性胸痹心痛、中风病等,可因强烈的情志刺激而诱发。长期持续性的精神刺激,如悲哀、忧愁、思虑过度易致气机郁滞或逆乱而缓慢发病,可引起消渴、胃脘痛、癥积等病的发生。因此,可以通过情志与脏

腑的对应关系,如怒——肝、悲——肺、喜——心、恐——肾等对相应脏腑进行疾病风险预警。

1.3 饮食致病风险预警 饮食致病包括:①饮食不节,如长期过饥预警脏腑失养;长期过饱预警脾胃疾病。②饮食不洁预警胃肠功能失调如泄泻、痢疾等病,寄生虫病,食物中毒等。③饮食偏嗜,这是最主要的饮食预警:五味偏嗜的预警,如《素问·生气通天论》^[10]曰:“味过于酸,肝气以津,脾气乃绝;味过于咸,大骨气劳,短肌,心气抑;味过于甘,心气喘满,色黑,肾气不衡;味过于苦,脾气不濡,胃气乃厚;味过于辛,筋脉沮弛,精神乃央”。食类偏嗜的预警,如《素问·奇病论》^[10]曰:“数食甘美而多肥……肥者令人内热,甘者令人中满,故其气上溢,转为消渴”。因此,可以建立一套饮食习惯——易出现的相关状态——易患疾病对应系统对相应疾病进行预警。

1.4 劳逸失度致病风险预警 劳逸失度主要有过劳:如劳力过度的“劳则气耗”“久立劳骨”“久行伤筋”等;劳神过度的暗耗心血,损伤脾气,“久视伤血”等;房劳过度的肾精、肾气耗伤等。过逸:如安逸少动,气机不畅,可出现食少胸闷,痰盛肥胖;正气虚弱,阳气不振,可出现易感外邪,或“久卧伤气”而精神萎靡等。劳逸失度致病尚需结合个人的生理病理、体质、职业等,才能更好地做出“过用”的预警,因此放在生理病理、体质因素与发病预警中去研究。

1.5 病理产物致病风险预警 病理产物往往又是致病因素,而且多为慢病的致病因素,因此一旦产生,便预示着可能会发生某些疾病,或者本身就是一种疾病。

痰饮:体检时多可发现痰饮的征象,痰的客观表现如形体肥胖、壅肿;身体某个部位的肿块,如痰核、瘰癧、瘰气、肿瘤,或肢体的肿胀,这些痰的特征,往往是客观的可以触摸得到或看到的,如楼英《医学纲目》^[11]曰:“凡有痰者,眼皮及眼下必有烟灰黑色,举目便知,不待切脉”,并且大多见舌苔滑腻等。

瘀血:瘀血产生的征象有身体某部位刺痛拒按,夜间尤甚;唇甲青紫,目眶暗黑,头发容易脱落;皮肤灰暗没有光泽,肤质粗糙,有皮屑,干燥,甚者如鱼鳞;眼白络脉终末紫斑,或舌下络脉曲张;体表皮肤出现紫斑、紫点;可见局部青紫肿胀的隆起;出血或经血紫暗有块;舌质紫暗,脉涩或结或代等。

结石:其形成多与饮食、情志、药物、体质、劳逸相关,故无需专列预警。

可以通过四诊采集得到的信息,参考生理病理、体质因素,经过加权运算得到各种病理产物如痰、湿、瘀等的诊断分值,并予以预警。

2. 疾病未发阶段的风险预警 中医学认为疾病的发病原理在于邪正相搏,即“外内合邪”所致。而影响发病的主要因素可归纳为自然环境因素、社会环境因素、体质因素和情志因素等方面。因此,中医学关于疾病未发阶段风险预警要立足于影响发病因素来研究,可分为因时预警,因地预警和因人预警的方案并编入疾病风险预警系统里。

2.1 因时预警 时,主要指四时,并延伸为时辰、昼夜、节气、运气等。时变则寒温气象随之变化,人的状态亦随之变化。一年四时气候呈现出春多风而温、夏多暑而热、秋多燥而凉、冬多寒而冷的节律性变化,人体的生理状态也相应地发生了适应性的变化。然而人类适应自然环境的能力是有一定限度的,如气候剧变,超过了人体调节机能的一定限度,或者机体的调节机能失常,不能对自然变化做出适应性调节时,人体就会发生疾病。这都说明,时间状态发生变化,人的状态也会相应地发生变化以维持人与自然的和谐状态,如果人的状态没有发生变化或者不能适应时间状态的变化,就可能导致疾病。因此,时间气候变化导致疾病发病的风险预警可与六淫致病风险预警结合,一起采用“五运六气”与现代气象信息的预警系统结合体质辨识系统进行年运节气等时间变化——风、火、暑、湿、燥、寒等——好发疾病的风险预警。

2.2 因地预警 中医学在探讨人体生理病理变化规律过程中充分认识到人对地域的依赖关系,将人体生理、病理与地域紧密地联系起来^[12]。《素问·异法方宜论》^[10]载有:“东方傍海而居之人易患痈疡,西方之人其病生于内,北方之人脏寒生满病,南方之人易病挛痹,中央之人易病痿厥寒热”。说明人类居处有方域不同,地势有高低险峻之殊,水土有厚薄之分,气候有冷暖干湿之异,当机体感受邪气,因人体禀赋强弱的差异,疾病的发生和发展也必将产生不同的影响。朱丹溪^[13]提出相火论也是根据“西北之人,阳气易于降;东南之人,阴火易于升”的特点,说明了地理环境对人体状态的影响是极其重要的。因此,需要查阅大量文献,如各地府志、县志和各种地方疾病的文献等,建立地方、地域——气候特点、水土性质、生活习俗——地域性多发病、常见病数据库,编入疾病风险预警系统。

2.3 因人预警

2.3.1 生活、工作及社会环境与预警:随着人们生活水平的不断提高,生活环境大为改善,生活环境对人们的影响逐步从卫生恶劣、蚊蝇孳生导致的许多传染病转为夜生活丰富的光、声、电磁扰所致的慢性非传染性疾病;工作环境阴暗潮湿易致阴盛之病,噪

音嘈杂易得阳盛之疾。此外尚有各种与工作环境相关的职业病等;社会现实突变与疾病的发生也有重大关系,如《素问·疏五过论》^[10]曰:“诊有三常,必问贵贱,封君败伤,及欲侯王?故贵脱势,虽不中邪,精神内伤,身必败亡。始富后贫,虽不伤邪,皮焦筋屈,痿痹为挛”。因此有必要建立个人的生活、工作、家庭及社会关系档案,通过对流行病学文献调研和临床数据采集,找到不同的生活、工作、家庭及社会环境与疾病的相关性,编入风险预警系统。

2.3.2 生理特点与预警:生命存在就是一个生长壮老已的过程。不同年龄、性别等生理特点,不同体质,都会有不同疾病的风险。如小儿既容易感受外邪而发感冒,也容易伤食而患脾胃病,且发病较急,转变较快;步入老年,“血气已衰,骨疏薄”,整个机体功能呈现衰弱态势,容易出现与衰老相关的疾病。再者由于男女在先天禀赋、身体形态、脏腑结构等方面的差异,相应的生理功能、心理特征也不同,因此健康状态也存在着性别差异。故如《医学正传·诸气》^[14]曰:“大抵男子属阳,得气易散,女人属阴,遇气多郁,是以男子之气病者常少,女人之气病者常多”。

不同生理病理特点好发疾病谱不同,风险因素影响程度不同,因此,可以对各种生理病理状态的人群进行相应好发疾病的预警。

2.3.3 体质特点与预警:体质是一种状态,也是一种趋势。把握了各种体质的本质特征及病变规律,可对疾病做出有效的预测和判断,以对疾病进行早期预警和早期治疗。目前有关体质的辨识主要通过症状进行辨别,如中医体质的各种量表,这与中医临床四诊信息采集有相同之处。这样的辨识,在一定程度上与证的辨识存在交叉,即反映的病理本质和参考价值相当。体质与证有不同内涵,体质的表现特点是在机体未病的状态时即有体现,证是在机体发病时的阶段性表现^[15]。任应秋^[16]教授指出“异病之所以同治,同病之所以异治,虽云决定于证,但就证的本质而言,仍关系于体质之有所不同”。体质对证的影响很大,陈家旭^[17]认为体质的差异导致病证的多变性,即体质是同病异证、异病同证的基础。不同的体质对疾病证的“从化”具有一定的制约性。如阳虚体质之人,患病后,证易从寒化、从湿化;阴虚体质之人,证易从热化、从燥化。在证的诊断方面,提出“据质求因,据质定性,据质明位,据质审势”。

人的体质可以通过外部的表征信息表现出来,因而对体质的辨识可以借鉴辨证的方法,即应用证素辨证的原理,通过每一症状对证素的贡献度进行加权积分,建立辨证的数学模型,从而对体质的判断也更加客观、准确。

3. 疾病未传阶段的风险预警 《素问·阴阳应象大论》^[10]曰:“故邪风之至,疾如风雨,故善治者治皮毛”,《伤寒论》^[18]中太阳病“欲作再经者,针足阳明,使经不传则愈”,这里“治皮毛”“欲作再经者”即强调早期治疗,既病防变,防止病情加重。但如何防变,防病情加重?首先就是要有疾病传变、加重的风险预警。《金匱要略·脏腑经络先后病脉证》提到“夫治未病者,见肝之病,知肝传脾,当先实脾”^[19],“若人能养慎,不令邪风干忤经络,适中经络,未流传脏腑,即医治之”^[19],强调了对病位扩大的风险预警,故叶天士提出“先安未受邪之地”。以上证例提示我们对疾病传变的预警可以立足在对证的判断上,以朱文锋证素辨证原理对当前证的病位、病性进行辨识,从病位的增减、深浅,以及病性的变化,对证的发展、转归作个预测,为既病防变和“截断疗法”提供疾病传变的预警。

4. 疾病未复阶段的风险预警 疾病病后状态又称瘥(差)后,是指疾病的基本证候解除后,到机体完全康复的一段时间,但机体正气不一定恢复正常。因此,疾病瘥后阴阳自和能力极不稳定,稍有不慎即可使故疾再起或罹患他病。因此,对病后态不可掉以轻心,要认真调护,以免变化众生而出现劳复、情志复、重感复、药复、自复等。瘥后复发可以看作是疾病传变的特殊形式,因此疾病复发的风险预警可以归类于疾病未传阶段的风险预警。

疾病风险预警的原理

疾病的病变过程中,人体的生理特点和病理变化往往有其共同规律和特殊规律。因此,每一种疾病都有基本的病理特点,如消渴的基本病理是阴虚燥热,肺癆的基本病理是阴虚燥热、癆虫袭肺,泄泻的基本病理是脾虚湿盛等^[15]。研究不同疾病的中医病理特点,能够为该病的预警和干预提供依据。同时研究发现,在疾病形成之前,机体常存在着某种病理变化趋势,这种病理特点同样也是疾病的易患因素之一。例如,高血压病除了与遗传因素、吸烟、饮酒、高盐饮食、精神应激等因素密切相关外,还可能与肾虚、肝郁、阳亢、血瘀、痰浊等因素有关,故从中医病理特点与相关疾病的关系,可以探讨该病的中医易患因素而提前预警^[15]。

既然中医学的疾病风险预警的原理来源于中医诊断学,结合现代临床流行病学研究,在证素辨证和体质辨识基础上,建立状态与疾病相关的模型构建而成的。中医学的疾病风险预警的研究方法是应用中医诊断学原理,延伸扩大到在整体观念指导下,通过全面、规范、准确地对所有人群,包括未病、欲病和已病等不同健康水平的群体,从宏观、中观、微观

层面各种状态进行四诊信息采集,并结合现代医学的体检指标采集,最后将所得到的数据与流行病学调查所得数据相结合,建立有关的数学模型或用电子计算机仿真,对慢病进行理论研究和临床验证,分析得出慢病形成的各种危险因素,从而对慢病进行风险预警。

结语

目前治未病理念虽然已经深入人心,然而对治未病的内涵众说纷纭。李灿东教授总结道,“治未病”就是消防,消防的目的是不着火而不是救火!是使人不生病、迟生病、生小病、病后容易治、治后不易复发。这首先要预知疾病的发生及病程的进展,因此对疾病风险预警的研究就是为治未病理念打造可操作平台,使治未病在临床实践中广泛应用,更好地推进中医健康事业发展。

参考文献

- [1] 李运明,刘丹红,孙彩虹,等.自评健康和健康风险评估方法的研究进展.中国全科医学,2011(22):2591-2592
- [2] 杨晓光,赵春媛.健康预警与疾病信号.北京:人民军医出版社,2012
- [3] 易璇,孙净,张卫红,等.加强健康教育预防,控制慢性非传染性疾病.中国民康医学,2009,21(4):399-400
- [4] 于锡峰.浅谈慢性非传染性疾病的预防和控制.医药,2016(1):108
- [5] 张树天,张玉峰.具有预警功能的热储备可修复平行系统.数学的实践与认识,2012(5):141-150
- [6] 吴清流.中医治未病思想在健康管理中的应用体会.心血管病防治知识(学术版),2013(10):16-18
- [7] 王珪.泰定养生主论.北京:中国医药科技出版社,2012:32
- [8] 孙思邈.备急千金要方.北京:中国医药科技出版社,2011:13
- [9] 徐大椿.医学源流论.北京:人民卫生出版社,2007:26
- [10] 黄帝内经·素问.北京:人民卫生出版社,2005:6,93,24-25,194,12
- [11] 楼英.医学纲目.北京:中国中医药出版社,1996:19
- [12] 郭蕾,乔之龙.认识天人相应的地球条件.现代中医报,2004,5:55-56
- [13] 震亨.丹溪心法.上海:上海科学技术出版社,1959:401
- [14] 虞抟.医学正传.何清湖编.太原:山西科学技术出版社,2013:296
- [15] 李灿东,杨朝阳,林雪娟,等.体质、病理特点、证与健康状态的关系.中华中医药杂志,2011,26(8):770-773
- [16] 谢有良,王勇,任廷革.任应秋早期学术思想探析.中医学报,2010,25(6):1078-1079
- [17] 陈家旭.体质因素在中医诊断中的意义.甘肃中医学院学报,1996,3(1):1-2
- [18] 张仲景.伤寒论.北京:人民卫生出版社,2005:25
- [19] 张仲景.金匱要略.北京:人民卫生出版社,2005:3

(收稿日期:2016年12月18日)